역류성 식도염 생활관리 안내

증상부터 식이·생활습관까지, 한눈에 이해하는 역류성 식도염

한국인 10명 중 1명이 겪는 흔한 병입니다

서구화된 식습관과 비만이 늘며 해마다 늘고 있습니다

7~13%

한국 성인 유병률

성인 약 10명 중 1명꼴입니다

2회+

일주일에 2번 이상

대표 증상이 이만큼 잦으면 진단을 생각합니다

왜 관리해야 하나요

그대로 두면 식도가 좁아지거나(협착) 식도 점막이 위 점막처럼 바뀌는 바렛식도로 진행할 수 있고, 드물게 식도암 위험을 높입니다.

대부분 잘 조절됩니다

알맞은 약물치료와 생활관리로 대부분의 환자는 증상을 잘 조절할 수 있습니다.

Tip · 흔한 병이지만, 오래가면 식도에 변화가 쌓이므로 꾸준히 관리합니다.

근거 · 미국소화기학회(ACG) 역류질환 진료지침 2022 · 대한소화기학회 역류성 식도염 진료지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

위 내용물이 식도로 거꾸로 올라오는 병입니다

위산이 식도 점막을 자극해 상처를 내는 만성 질환입니다

식도와 위 사이의 조임근이 약해짐

평소 닫혀 있어야 할 식도-위 경계(하부식도괄약근)가 약해지면 산성 위 내용물이 식도로 올라옵니다.

배 속 압력이 올라감

뱃살·과식·꽉 끼는 옷처럼 배 속 압력을 높이는 요인이 겹치면 역류가 더 쉬워집니다.

반복되면 합병증

역류가 되풀이되면 식도염, 식도가 좁아지는 협착, 바렛식도로 이어질 수 있습니다.



설명용 그림 · 위산(주황색)이 식도로 올라와 가슴쓰림·기침·신물을 일으킵니다.

Tip · 조임근 기능 저하와 배 속 압력 증가 — 이 두 가지가 만나는 곳에서 역류가 시작됩니다.

근거 · 대한소화기학회 역류성 식도염 진료지침 · 미국소화기학회(ACG) 역류질환 진료지침 2022

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

이런 증상이 있나요

대표 증상과 함께, 역류가 원인인 줄 모르기 쉬운 증상도 살펴봅니다

대표 증상

역류성 식도염에서 흔히 겪습니다

- 가슴쓰림 — 가슴 한가운데가 타는 듯함, 식후·누우면 심해짐
- 신물·쓴물 — 위 내용물이 입까지 올라옴
- 잦은 트림·소화불량 — 식후 부글거림·더부룩함

vs

놓치기 쉬운 증상

역류가 원인일 수 있습니다

- 3주 넘는 기침·쉰 목소리
- 목에 무엇이 걸린 듯한 이물감이 반복됨
- 밤에 가슴 통증 — 심장 원인을 먼저 확인한 뒤 역류를 생각합니다

Tip · 3주 넘게 기침이 계속되면 역류도 한 번쯤 의심해 봅니다.

근거 · 몬트리올 정의 2006 · 리옹 합의 2.0 2023

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

왜 생기나요

조임근이 풀리고 배 속 압력이 오르는 일이 일상에서 쌓입니다

체중·배 속 압력

비만·복부비만은 역류 위험을 높입니다. 2025년 연구에서 체질량지수(BMI)가 10 높을 때 역류질환 위험은 약 68% 높았습니다.

식습관

과식·야식·식후 바로 눕기·기름진 음식은 위가 비워지는 것을 늦춥니다.

담배·술·카페인

식도와 위 사이 조임근을 직접 느슨하게 만듭니다.

먹는 약

일부 혈압약(칼슘차단제)·협심증약(질산염)·천식약 — 먹는 약을 함께 점검합니다.

구조 이상

위 일부가 가슴 쪽으로 올라가는 식도열공탈장이 함께 있을 수 있습니다.

스트레스

증상을 더 예민하게 느끼게 하고 식습관도 나빠지게 합니다.

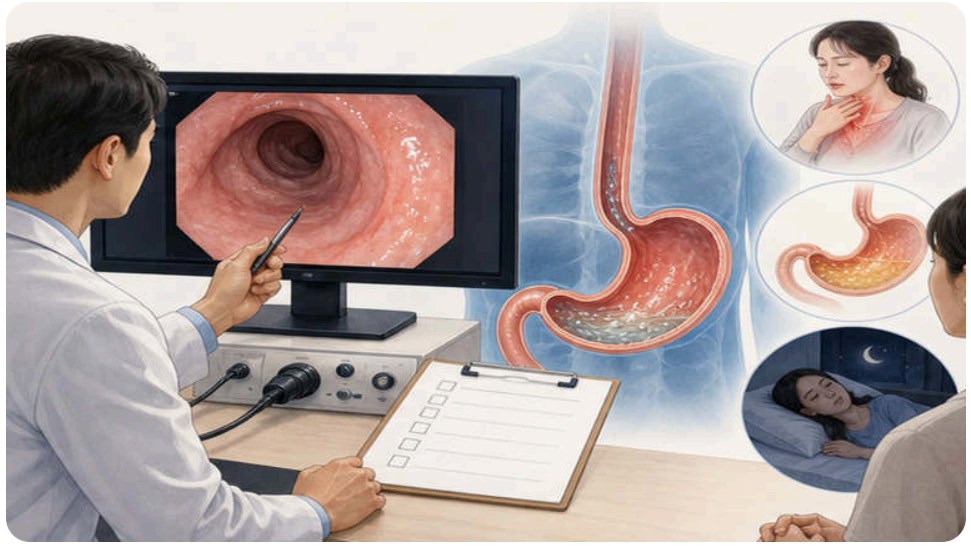
Tip · 바꿀 수 있는 원인부터 — 체중·식습관·담배·술이 상담의 우선순위입니다.

근거 · ACG 역류질환 지침 2022 · Mao, Frontiers in Physiology, 2025

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

어떻게 진단하나요

대표 증상이 뚜렷하면 먼저 진단하고 약으로 치료를 시작합니다



설명용 그림 · 의사가 내시경 화면으로 식도를 살펴봅니다. 목·위·밤 증상도 함께 확인합니다.

1 증상 확인 진료

증상이 얼마나 잦은지, 체중 감소·삼킴 곤란·출혈 같은 위험 신호가 있는지 봅니다.

2 위산억제제 시험 치료 8주

위험 신호가 없다면 위산억제제(PPI)를 식전 하루 한 번 8주 복용합니다.

3 위 내시경 필요할 때

위험 신호가 있거나 약이 잘 안 듣거나 50세 이상에 새로 생긴 증상일 때. 식도염 정도를 A~D 네 단계(LA 분류)로 나눕니다.

4 정밀 검사 드물게

24시간 식도 산도·임피던스 검사, 식도 운동(내압) 검사 — 약이 안 듣거나 수술을 생각할 때.

Tip · 모든 분이 내시경부터 하지는 않습니다 — 위험 신호가 있으면 먼저 합니다.

근거 · 미국소화기학회(ACG) 역류질환 진료지침 2022 · 리옹 합의 2.0 2023

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

약물 치료 — 위산을 줄이는 것이 중심입니다

처방받은 기간을 지키는 것이 가장 중요합니다 — 내시경으로 확인된 경우 건강보험이 적용됩니다

약 종류	대표 약과 먹는 법
위산억제제(PPI) 1차 치료	에소메프라졸 등 · 식전 30~60분 · 하루 한 번 8주 시험 치료
칼륨경쟁적 위산억제제	테고프라잔·보노프라잔 · 식사와 상관없이, 빠르게 위산을 줄임
H2 차단제·제산제	증상이 가벼울 때 보조로 · 바로 가라앉히려면 물약 제산제
위장운동 촉진제	위가 늦게 비워질 때 보조로 · 이것만 단독으로는 권하지 않음



설명용 그림 · 정해진 시간에 약을 먹으면 위산이 줄어 식도 점막이 회복됩니다.

Tip · 좋아져도 처방 기간은 지키세요 — 갑자기 끊으면 위산이 오히려 늘 수 있습니다.

근거 · 미국소화기학회(ACG) 역류질환 진료지침 2022 · 대한소화기학회 역류성 식도염 진료지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

음식 — 피할 것과 권하는 것

사람마다 다릅니다. 내 증상을 나빠지게 하는 음식부터 피하세요

내게 맞으면 줄이기

증상을 부르기 쉬운 음식·습관 — 일괄 금지는 아닙니다

- 기름진 음식·튀김, 맵고 향신료가 강한 음식
- 커피·홍차·콜라 같은 카페인 음료
- 초콜릿·박하사탕
- 술(특히 밤에 마시는 술)
- 오렌지·토마토 같은 신 과일, 탄산음료·야식

vs

권장

역류를 줄이는 먹는 방법

- 천천히, 잘 씹어 먹기
- 한 번에 먹는 양은 줄이고 여러 번 나눠 먹기
- 식후 2~3시간은 눕지 않기 · 잠들기 2~3시간 전 식사 마치기
- 현미·채소·통곡물 같은 식이섬유
- 생선·닭가슴살 같은 저지방 단백질, 미지근한 물

Tip · 일괄 금지보다 — 먹고 나서 증상이 생긴 음식을 기록해 내 유발 음식을 찾아보세요.

근거 · 미국소화기학회(ACG) 역류질환 진료지침 2022 · 대한소화기학회 역류성 식도염 진료지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

생활습관 — 약의 효과를 좌우합니다

약과 함께 반드시 실천하세요

1. **적정 체중 유지** 근거 가장 강함
   5~10% 감량은 지침 수치가 아닌 관행적인 목표입니다. 개인 목표는 진료에서 정합니다.
2. **금연·절주**
   담배·술은 조임근을 느슨하게 해 역류를 직접 일으킵니다.
3. **상체를 높여 자기** 15~20cm
   침대 머리 쪽 다리를 높이거나 쐐기형 베개 — 베개만 높이면 효과가 덜합니다.
4. **배 조이지 않기**
   꽉 끼는 벨트·옷을 피하고 식사 직후 허리 굽히기를 줄입니다.
5. **식후 가벼운 활동**
   식후 바로 눕거나 격렬한 운동은 피하고 가볍게 걷습니다.
6. **왼쪽으로 누워 자기**
   오른쪽보다 밤사이 역류가 줄었다는 보고가 있습니다.



설명용 그림 · 저녁을 일찍 가볍게 먹고, 상체를 높여 왼쪽으로 눕고, 체중을 관리합니다.

Tip · 생활습관 가운데 근거가 가장 강한 것은 체중 감량입니다.

근거 · ACG 역류질환 지침 2022 · 서울 합의 2020 — 5~10%는 지침 수치 아님

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

금연 · 절주 · 운동 · 호흡 훈련

약·식사와 함께 챙기면 좋은 습관입니다

금연 — 전자담배도

니코틴은 조임근을 느슨하게 하고 침을 줄입니다. 정상 체중·약을 안 쓰는 분에서 끊으면 심한 증상이 뚜렷이 줄었습니다.

절주 — 양과 때

마실수록 위험이 오릅니다. 줄였을 때의 연구는 부족해, 식후 많이·잠들기 전 마시는 술부터 줄입니다.

운동 — 주 150분 중강도

규칙적인 중강도 유산소 운동은 역류 위험을 낮춥니다(33편·242,850명 분석).

식후 바로 강한 운동은 피하기

식후 2시간 안의 달리기·무게 운동·윗몸일으키기는 배 속 압력을 갑자기 올려 역류를 부릅니다.

복식호흡 — 바깥 조임쇠

배로 숨 쉬는 훈련으로 식도 아래 조임이 강해지고 식후 역류·증상·삶의 질이 좋아졌습니다.

복식호흡 — 하루 20분 · 4주

매일 20분씩 4주 넘게 했을 때의 결과입니다. 미국소화기협회(AGA) 2022 권고에 들어 있습니다.

Tip · 운동은 식사 2시간 뒤, 호흡 훈련은 식후에 천천히 해 보세요.

근거 · HUNT(PMID 24322837) · Pan 2019 · 운동 메타분석 2024 · 미국소화기협회(AGA) 2022

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

이럴 땐 바로 진료를 받으세요

혼자 관리하지 마세요 — 출혈이나 심한 가슴 통증은 바로 응급실로 갑니다

삼키기 어려움

음식이 걸리거나 잘 안 넘어갑니다. 식도가 좁아졌거나 종양인지 확인해야 합니다.

뜻하지 않은 체중 감소

3~6개월 사이 체중이 5% 넘게 빠졌을 때.

검은 변·피를 토함

검은 변, 피를 토함, 커피 찌꺼기 같은 구토물 — 출혈일 수 있어 바로 응급실로.

처음 겪는 가슴 통증

심장 원인부터 확인합니다. 쥐어짜듯 아프고 식은땀이나 숨참이 있으면 119.

약이 잘 안 들을 때

위산억제제를 8주 충분히 먹어도 증상이 남거나 다시 생깁니다.

50세 이상 새 증상

늦게 시작된 역류 증상은 꼭 내시경으로 확인합니다.

Tip · 위험 신호가 있으면 약이 듣든 안 듣든 내시경 검사를 받습니다.

근거 · 미국소화기학회(ACG) 역류질환 진료지침 2022

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

오늘부터 실천할 일곱 가지

작은 습관 변화가 약물치료의 효과를 결정합니다

01 식후 2~3시간은 눕지 않기

02 잠들기 2~3시간 전까지 식사 마치기

03 야식·과식 끊기

04 커피·술·담배 줄이거나 끊기

05 잠자리 머리 쪽 15~20cm 높이기

06 꽉 끼는 옷·벨트 피하기

07 처방약은 마음대로 끊지 않고 먹기

Tip · 8주 꾸준히 지키면 증상이 좋아지는 경우가 많습니다 — 매일 체크해 습관으로 만드세요.

근거 · 미국소화기학회(ACG) 역류질환 진료지침 2022 · 대한소화기학회 역류성 식도염 진료지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

QR로 다시 보기 · 집에서 실천할 내용은 한 장 안내문으로 드립니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

역류성 식도염 진단을 받았거나 증상이 있는 분을 위한 생활관리 설명자료입니다. 약과 검사는 담당 의사와 상의해 정합니다.

참고한 자료

미국소화기학회(ACG) 역류질환 진료지침 2022 · 대한소화기학회 역류성 식도염 진료지침 · 몬트리올 정의 2006 · 리옹 합의 2.0 2023

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요